



נוהל מס': 039.18
שם הנוהל: מניעת קרעים פרינאליים
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי

תאריך פרסום: 20/2/18 תאריך עדכון	תחום הנוהל: מיילדות		תפוצה: מחלקת נשים ויולדות
	שם הנוהל: מניעת קרעים פרינאליים		
נספחים: 1. אופן הנחת רטיות חמות 2. אופן ביצוע מסאג' פרינאלי	מאשר הנוהל: פרופ' זאב ויינר	כותב הנוהל: ד"ר עומר מור, ד"ר יובל גינסברג	מס' דפים: 9
	על החתום:	על החתום:	

רשימת עדכונים

מהדורה	מהות העדכון	שם המעדכן ותפקיד	תאריך

מילות מפתח (KEY WORDS)

מסאג' פרינאלי, רטיות חמות, DELAYED PUSHING, מניעת קרעים OASIS

תוכן העניינים

העמוד	הנושא
2	1. רקע
3	2. מטרות הנוהל
3	3. הגדרות ומונחים
3	4. סמכות ואחריות
3	5. עקרונות הנוהל
6	6. דיווח ותיעוד
6	7. סימוכין (אסמכתאות)
8	8. נספחים ותמונות

1. רקע

שיעור הקרעים הפרינאליים משתנים לפי אוכלוסיות, התנהלות הלידה וניהול הלידה. 53-79% מהנשים יחוו אחד מסוגי הקרעים בכל לידה נרתיקית כשהרוב המוחלט הם קרעים בדרגה 1 ו 2. (1)

קלסיפיקציה של קרעים פרינאליים וטיפול בהם מופיעים תחת הפרק המתאים בפרוטולים המחלקתיים. מסמך זה יפרט את הדרכים למנוע קרעים בדרגה 3 ו 4 הנקראים גם (OASIS) OBSTETRIC ANAL SPHINCTER INJURIES. גורמי הסיכון לקרעי OASIS הם:

Odds Ration	גורם סיכון
OR, 5.65; 95% CI, 5.55–5.75 OR, 10.55; 95% CI, 10.29–10.81	לידת מלקחיים + אפיזיוטומיה מדיאלית קרע דרגה 3 ו 4
OR, 5.50; 95% CI, 3.17–9.55	לידת מלקחיים
OR, 3.98; 95% CI, 2.60–6.09	לידת ואקום
OR, 3.82; 95% CI, 1.96–7.42	אפיזיוטומיה מדיאלית
OR 3.24; CI 95%, 2.2-4.76	מבכירות
OR, 3.09; 95% CI, 1.81–5.29	OCCIPUT POSTERIOR
OR, 2.74; 95% CI 5.72–1.31 ,	מוצא אסייתי
OR, 1.95; 95% CI, 1.56–2.44	אוגמנטציה של לידה
OR, 1.95; 95% CI, 1.66–2.32	הרדמה אפידוראלית
RR, 95% ;1.9 CI, 1.6–2.3 and RR, 1.7; 95% CI, 1.6–1.7	היסטוריה משפחתית של קרעי OASIS אצל האם והאחות
OR, 1.08; 95% CI, 1.02–1.14	אינדוקציה של לידה

2. מטרות הנוהל:

- א. קביעת אמצעים למניעה של קרעים פרינאליים במחלקתינו
- ב. פירוט מדויק של אופן ביצוע פעולות למניעת קרעים בדרגה 3,4

יש להדגיש כי למרות השאיפה ליישום ההנחיות הכתובות בנהל זה, אין אפשרות ועל כן אין חובה ליישמו בכל לידה. יש להדגיש כי בכל מקרה לא ניתן למנוע לחלוטין קרעים במהלך לידה.

3. הגדרות ומונחים:

- א. קרעי OASIS - קרעים פרינאליים דרגה 3 ו 4

4. סמכות ואחריות:

רופאים ומיילדות בחדרי לידה אשר הוסמכו לביצוע הנוהל על ידי מנהל חדרי הלידה או מיילדת אחראית

5. עיקרי הנוהל:

אסטרטגיות למניעת קרעים פרינאליים:

הגנה על הפרינאום:

הגנה על הפרינאום בזמן יציאת ראש העובר כמפורט בתמונה מספר 2 - מהווה הגנה מפני קרעים 3, 4 לעומת Hands off (RR 0.45; 95% CI 0.40–0.50) (10).

מסאז' פרינאלי:

מסאז' פרינאלי לפני הלידה או תוך כדי הלידה אמור להפחית שיעור קרעים פרינאליים במנגנון של הורדת מתח וטונוס השרירים הפרינאליים. מסאז' פרינאלי בנשים מבכורות, המתבצע החל משבוע 34 להריון, מוריד על פי מספר מחקרים את השיעור לקרעים פרינאליים והצורך בביצוע אפיזיוטומיות בצורה מעטה ($0.91-RR$ ו $0.84-RR$ בהתאמה) (3). נשים שכבר ילדו בעברן חוו לפי אותם מחקרים שיעור כאב ממקור פרינאלי נמוך יותר אם ביצעו מסאז' פרינאלי החל משבוע 34 להריון ($0.45-RR$).

מסאז' פרינאלי בזמן השלב השני של הלידה נחשב כיילוד "HANDS ON" ומתבצע בעזרת פלקסיה של השרירים הפרינאליים או בשיטה על שם RINTGEN (תמונה מספר 1). מסאז' פרינאלי בזמן השלב השני של הלידה מוריד את ההיארעות של קרעים דרגה 3 ו 4 ($0.52-RR$) אך לא מוריד את שיעור הקרעים מדרגה 2 ו 1. (4). מטה אנליזה נוספת שבוצעה היתה חלוקה במסקנותיה. מספר מחקרים (6647 נשים) הראו שאין קשר מגן בין מסאז' פרינאלי בשלב 2 של הלידה וקרעים מסוג 3 ו 4 OASIS – ואחרים (74,744 נשים) הראו קשר מגן חזק ומובהק ($0.45-RR$ עם $0.40-0.50$ CI). הטכניקות בהן בוצע המסאז' לא פורטו במחקרים אלו אשר אוחדו למטה אנליזה והמסקנה מהמטה אנליזה הזו הייתה שהנתונים הקיימים אינם מספיקים להמליץ על מסאז' פרינאלי בזמן השלב השני של הלידה להפחתת קרעים פרינאליים. (5)

רטריות חמות (קומפרסים):

קומפרסים חמים בשלב שני של הלידה הוכחו ב RANDOMIZED CONTROL STUDIES עם כ 1525 נשים כמפחיתים את שיעור קרעי ה OASIS בצורה מובהקת ($0.48-RR$) אך לא הורידו את שיעור הקרעים הקלים יותר בדרגה 1 ו 2 (1.05 RR) לא מובהק סטטיסטית). במחקרים אלו, הנשים הגדירו את הקומפרסים כ"מתקבלים על הדעת" בביצוען ועל כן אין מניעה להציע את הטכניקה הזו למניעת קרעים (3)

נוהל מס': 039.18
שם הנוהל: מניעת קרעים פרינאליים
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



איחור הלחיצות האקטיביות בלידה (DELAYED PUSHING):

מחקרים רבים נעשו על השפעת איחור הלחיצות האקטיביות בלידה על שיעור הקרעים הפרינאליים. המחקרים השוו בין הלחצה מוקדמת של היולדת (עד שעה מפתחה מלאה) להלחצה מאוחרת של היולדת (1-3 שעות מפתחה מלאה) ומצאו כי אין הבדל בשיעור הקרעים הפרינאליים או בשיעור הצורך באפיזיוטומיה בין שתי הקבוצות. (6). יש לציין שהסקירה שהשוותה בין שתי הקבוצות הייתה מקיפה וכללה 9 מחקרים עם 2953 נשים.

תנוחת היולדת:

תנוחת יילוד יכולה להשפיע על שיעור הקרעים הפרינאליים. מחקר RCT מהשנה האחרונה בדק תנוחת יילוד לטרלית משולבת עם הלחצה מאוחרת בהשוואה לתנוחת ליטוטומי עם הלחצה מוקדמת ומצא כי נשים שילדו בתנוחת לידה לטרלית עם הלחצה מאוחרת חוו בצורה מובהקת פחות קרעים פרינאליים מהקבוצה השניה (12% לעומת 40% $P < 0.001$). (7) במחקרים אחרים באותו נושא, לא נצפו פחות קרעים אצל נשים שילדו בקריעה או בעמידה לעומת כאלו שילדו בשכיבה או בתנוחת ליטוטומי. (8)

המלצות מתוך ה – PRACTICE BULLETIN OF THE AMERICAN

(9) COLLEGE OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGISTS

1. קומפרסים חמים בזמן לחיצות אקטיביות מורידים את השכיחות של קרעים מדרגה 3 ו 4, מומלץ לצוותים רפואים לטפל כך בכל יולדת (LEVEL A).
2. מסאז' פרינאלי במן שלב שני של הלידה מומלץ להפחתת השיעורים של קרעי (LEVEL B) OASIS
3. אם יש צורך בביצוע אפיזיוטומיה בעת הלידה – אפיזיוטומיה מדיו-טרלית עדיפה על פני אפיזיוטומיה מדיאלית להגנה כנגד קרעים המערבים את הספינקטר האנאלי. חשוב לציין כי אפיזיוטומיות מדיו-טרליות גורמות ליותר כאבים פרינאליים ול (LEVEL B) dyspareunia

נוהל מס': 039.18
שם הנוהל: מניעת קרעים פרינאליים
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



דיווח ותיעוד

יש לתעד בסיכום הלידה את דרגת הקרע ואת הטכניקה שבוצעה למניעת הקרע.

סימוכין:

1. Smith LA, Price N, Simonite V, Burns EE. Incidence of and risk factors for perineal trauma: a prospective observational study. BMC Pregnancy Childbirth 2013;13:59
2. Pergialiotis V, Vlachos D, Protopapas A, Pappa K, Vlachos G. Risk factors for severe perineal lacerations during childbirth. Int J Gynaecol Obstet 2014;125:6–14
3. Beckmann MM, Stock OM. Antenatal perineal massage for reducing perineal trauma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4.
4. Aasheim V, Nilsen AB, Lukasse M, Reinart LM. Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 12
5. Bulchandani S, Watts E, Sucharitha A, Yates D, Ismail KM. Manual perineal support at the time of childbirth: a systematic review and meta-analysis. BJOG 2015;
6. Roberts CL, Torvaldsen S, Cameron CA, Olive E. Delayed versus early pushing in women with epidural analgesia: a systematic review and meta-analysis. BJOG
7. Walker C, Rodriguez T, Herranz A, Espinosa JA, Sanchez E, Espuna-Pons M. Alternative model of birth to reduce the risk of

- assisted vaginal delivery and perineal trauma. *Int Urogynecol J* 2012;23:1249–56.
8. Kemp E, Kingswood CJ, Kibuka M, Thornton JG. Position in the second stage of labour for women with epidural anaesthesia. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2013, Issue 1.
 9. Practice Bulletin No. 165: Prevention and Management of Obstetric Lacerations at Vaginal Delivery ,*Obstetrics & Gynecology*: July 2016 - Volume 128 - Issue 1 - p e1–e15
 10. Bulchandani, S., Watts, E., Sucharitha, A., Yates, D., & Ismail, K.M. (2015). Manual perineal support at the time of childbirth: a systematic review and meta-analysis. *BJOG*

נוהל מס': 039.18
שם הנוהל: מניעת קרעים פרינאליים
התחום באקרידיטציה: לא רלבנטי



נספחים

אופן ביצוע הנחת קומפרסים חמים:

- יש להסביר ליולדת על האפשרות לבצע הנחת קומפרסים חמים על מנת למנוע קרע פרינאלי. יש להציג את העובדה כי הוכח במחקרים שהנחת קומפרסים חמים בשלב השני של הלידה יכולה להפחית פי 2 את שיעור הקרעים בדרגה 3 ו 4 אך איננה מורידה את שיעור הקרעים בדרגה 1 ו 2. יש לקבל את הסכמת היולדת לביצוע התהליך.
- יש להכין כלי גדול ואליו לשפוך ליטר אחד של SALINE מחומם.
- במקביל לכלי החם יש להכין 2 חבילות מרפדים יבשים.
- יש לתת ליולדת לחוש את טמפרטורת המים על היד לפני ביצוע האלחוש.
- בזמן השלב השני יש לטבול פד במים החמים ולהניח על הפריניאום.
- יש להחליף את הפד כעבור מספר דקות לאחר שהוא מגיע לטמפרטורת הגוף.
- אין קשר למיקום הראש בתעלה ולביצוע הנ"ל. יש לבצע מספר מרבי של הנחת מרפדים חמים מפתיחה מלאה ועד ללידה בהתאם להרגשת היולדת.
- כשהמים מתקררים בכלי הגדול – יש להחליפן במים חמים בשנית

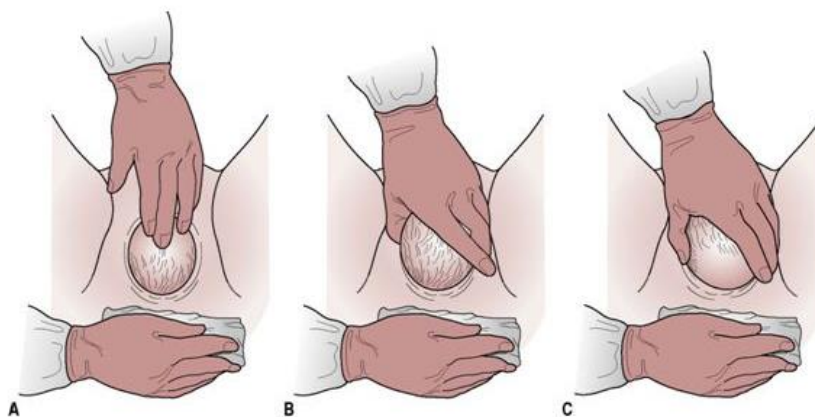
אופן ביצוע מסאז' פרינאלי:

- יש להסביר ליולדת על האופן בו מתבצע המסאז' ועל העובדה כי מדובר באמצעי שההמלצה לגביו חלוקה, אך אין לשלול אותו כאמצעי מגן כנגד קרעים 3 ו 4.

2. יש לבצע את המסאז' בעזרת ג'ל על בסיס מים מפתיחה גמורה ועד ללידה
3. אופן הביצוע – יש להכניס את האגודלים בין השפתיים הגדולות ולבצע תנועות אופקיות כמתואר בתמונה הבאה:



תמונה מספר 2



Supporting the head. (A) Preventing rapid extension. (B) Controlling the crowning. (C) Easing the perineum to release the face.